PARTE I | PLANO NACIONAL 2027 A 2030

Saúde dos Povos Indígenas

Plano de execução da Presidência da República para a saúde dos povos indígenas, com metas mensuráveis, governança por resultados e base nas políticas públicas em vigor

Apresentado à **Presidência da República**

pelo Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul, em consonância com o programa de governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 2027 a 2030 e com as políticas do Ministério da Saúde e da SESAI

1,69 milhão	53,97%	2,4 vezes	31 metas
pessoas indígenas no Censo 2022	vivem em áreas urbanas	a mortalidade de crianças menores de 5 anos	verificáveis em 11 eixos até 2030

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 26 de outubro de 2026

FICHA TÉCNICA

Título	Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas 2027 a 2030
Natureza	Proposta técnica de política pública, para execução pela Presidência da República por meio de decreto e de atos do Ministério da Saúde
Destinatário	Presidência da República, Casa Civil, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde Indígena e Ministério dos Povos Indígenas
Horizonte	1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2030, com entregas em 100 dias, 12 meses e 48 meses
Base de evidências	Censo Demográfico 2022 (IBGE), Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI), SIM e SINASC, informes da SESAI e do COE Yanomami, literatura científica revisada por pares e a proposta técnica de saúde indígena urbana do CMDDI de Campo Grande
Proponente	Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul (FOCAMS), presidido por Aguinaldo de Arruda Areco
Responsáveis pelos projetos	Maria Auxiliadora Bezerra, Presidente do Instituto Cacique Enir Terena (consultoria institucional técnica) Germano Coelho Ramos Rocha-Silva, Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação
Contribuições incorporadas	Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande (CMDDI) e Instituto Cacique Enir Terena (ICET)

Este documento traduz em política de Estado o direito à saúde diferenciada que a Constituição e a Lei nº 9.836/1999 asseguram aos povos indígenas. Ele não depende de lei nova para começar: as medidas dos primeiros 100 dias cabem em decreto presidencial e em portarias ministeriais. As propostas que pedem lei estão identificadas como tais, com a minuta correspondente.

Todos os números trazem a fonte. Onde a linha de base ainda não existe de forma confiável, o Plano estabelece como primeira tarefa a sua medição.

Sumário

Siglas 25

Sumário executivo 26

1 Justificativa da coordenação presidencial 28

2 Diagnóstico em números 29

3 Fundamentos jurídicos e salvaguardas 34

4 Alinhamento com o programa de governo 36

4.1 Políticas federais em vigor que o Plano aproveita 36

4.2 A resposta à emergência Yanomami 37

4.3 As propostas de saúde do programa de governo 37

5 Arquitetura do Plano 39

6 Os onze eixos de execução 40

7 Painel de metas e indicadores 48

8 Governança e execução 51

9 Financiamento e responsabilidade fiscal 53

10 Cronograma e entregas dos 100 dias 54

11 Riscos e respostas 55

12 Monitoramento, avaliação e transparência 56

13 Conclusão 57

Referências 58

Anexo A. Minuta de decreto presidencial 60

Anexo B. Minuta de projeto de lei da saúde indígena na cidade 62

Siglas

ADPF	Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
AgSUS	Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde
AIS	Agente Indígena de Saúde
AISAN	Agente Indígena de Saneamento
APS	Atenção Primária à Saúde
CASAI	Casa de Apoio à Saúde Indígena
CMDDI	Conselho Municipal dos Direitos e Defesa dos Povos Indígenas de Campo Grande
COE	Centro de Operações de Emergências
CONDISI	Conselho Distrital de Saúde Indígena
DSEI	Distrito Sanitário Especial Indígena
EMSI	Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena
FOCAMS	Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
LDO, LOA	Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018)
OIT	Organização Internacional do Trabalho
PNASPI	Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas
PNI	Programa Nacional de Imunizações
RAPS	Rede de Atenção Psicossocial
RNDS	Rede Nacional de Dados em Saúde
SAMU	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
SasiSUS	Subsistema de Atenção à Saúde Indígena do SUS
SESAI	Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde
SIASI	Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena
SIM, SINASC	Sistema de Informações sobre Mortalidade, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos
UBSI	Unidade Básica de Saúde Indígena

Sumário executivo

O Brasil tem 1.694.836 pessoas indígenas, de 391 etnias, falantes de 295 línguas. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena atende 821.314 delas por meio de 34 Distritos Sanitários, 388 Polos Base, 1.211 Unidades Básicas e 70 Casas de Apoio, com mais de 22 mil trabalhadores. Trata-se de uma rede de atenção diferenciada de grande porte. Ainda assim, uma criança indígena brasileira tem 2,4 vezes mais chance de morrer antes dos cinco anos do que uma criança não indígena, a tuberculose incide 2,5 vezes mais e o suicídio mata quase três vezes mais.

A rede de atenção existe e foi fortalecida desde 2023. O desafio agora é medir resultados, orientar a gestão por metas e estender o cuidado a quem ainda não é alcançado: os 914.746 indígenas que vivem nas cidades, maioria absoluta da população indígena desde o Censo 2022, para quem o acesso ao atendimento diferenciado ainda é limitado.

O **Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas** propõe à Presidência da República onze eixos de execução, 31 metas verificáveis e um modelo de governança por resultados, em que cada Distrito Sanitário assina um acordo de metas, publica seus números todos os meses e responde por eles. O Plano usa a estrutura que já existe, não cria entidade nem cargo novo e parte de políticas em vigor, considerando as deliberações já aprovadas pelas instâncias de controle social da saúde indígena. Ele será enviado ao Conselho Distrital de Saúde Indígena de Mato Grosso do Sul (CONDISI-MS), para que o conselho, se assim decidir, o inclua em seu planejamento. Começa por decreto, em 100 dias.

Principais metas até 2030

1. Reduzir a mortalidade de menores de cinco anos de 34,7 para no máximo 26 por mil nascidos vivos, com queda da desigualdade em relação às crianças não indígenas de 2,4 para 1,8 vez.
2. Reduzir em 20% a mortalidade por suicídio no Subsistema, com prioridade para Mato Grosso do Sul.
3. Reduzir em 25% a incidência de tuberculose e chegar a 85% de cura dos casos novos.
4. Manter em zero os óbitos evitáveis por malária na Terra Indígena Yanomami e estender o modelo de resposta às demais áreas endêmicas.
5. Conectar 100% das 1.211 Unidades Básicas de Saúde Indígena e levar a telessaúde especializada aos 34 Distritos.
6. Implantar o prontuário eletrônico indígena integrado à Rede Nacional de Dados em Saúde em todas as equipes.
7. Criar a atenção diferenciada aos indígenas urbanos, a começar por um projeto piloto em Campo Grande, que reúne cerca de 18,4 mil indígenas organizados em aldeias urbanas, e expandir para as regiões metropolitanas prioritárias.
8. Elevar de 716 para no mínimo 1.000 o número de médicos em atuação nos territórios.
9. Exigir Avaliação de Impacto em Saúde de toda atividade produtiva autorizada em terra indígena.
10. Publicar, todo mês, o painel de resultados dos 34 Distritos, com dados abertos e contratos vinculados a metas.

O Plano dá continuidade às políticas do governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a saúde indígena, como o Mais Médicos, o Agora Tem Especialistas, o SUS Digital e a resposta à emergência Yanomami, e as organiza em metas verificáveis para 2027 a 2030 (capítulo

4).

1 Justificativa da coordenação presidencial

A saúde indígena é responsabilidade exclusiva da União. O art. 19-C da Lei nº 8.080/1990, incluído pela Lei nº 9.836/1999, atribui à União o financiamento do Subsistema com recursos próprios. Não há estado ou município a quem transferir a conta, e por isso o resultado depende diretamente da prioridade que o governo federal lhe dá.

Entre 2019 e 2022 o Subsistema enfrentou a Covid-19 e o agravamento da crise humanitária na Terra Indígena Yanomami, que levou à declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em janeiro de 2023. A partir de então, a reconstrução da política foi acompanhada por um processo estrutural no Supremo Tribunal Federal, a ADPF 709, encerrado em setembro de 2025, depois que a Corte reconheceu avanços na definição do público atendido, na metodologia de distribuição de recursos aos Distritos e na criação de critérios técnicos para o orçamento a partir de 2027.

O encerramento da ADPF 709 abre uma janela rara. Pela primeira vez em seis anos, o desenho da política volta a depender exclusivamente do Poder Executivo, e o PLOA 2027 será o primeiro orçamento com critérios técnicos de redistribuição entre os Distritos. Um plano presidencial, instituído por decreto e acompanhado de perto pela Casa Civil, é o instrumento que transforma essa janela em resultado.

Há três razões para que a coordenação seja da Presidência, e não apenas do Ministério da Saúde:

- Os determinantes da saúde indígena estão, em grande parte, fora do setor saúde. Água, alimentação, conectividade, logística aérea, segurança nos territórios e renda dependem de pelo menos oito ministérios. Sem coordenação central, cada um age no seu tempo.
- Parte dos problemas mais graves ocorre em áreas de fronteira. O garimpo ilegal, o tráfico e a malária na faixa de fronteira exigem as Forças Armadas, a Polícia Federal e a diplomacia ao lado das equipes de saúde, como mostrou a resposta na Terra Yanomami.
- O acompanhamento mensal dos indicadores pela Presidência permite identificar e corrigir falhas com mais rapidez do que os relatórios anuais.

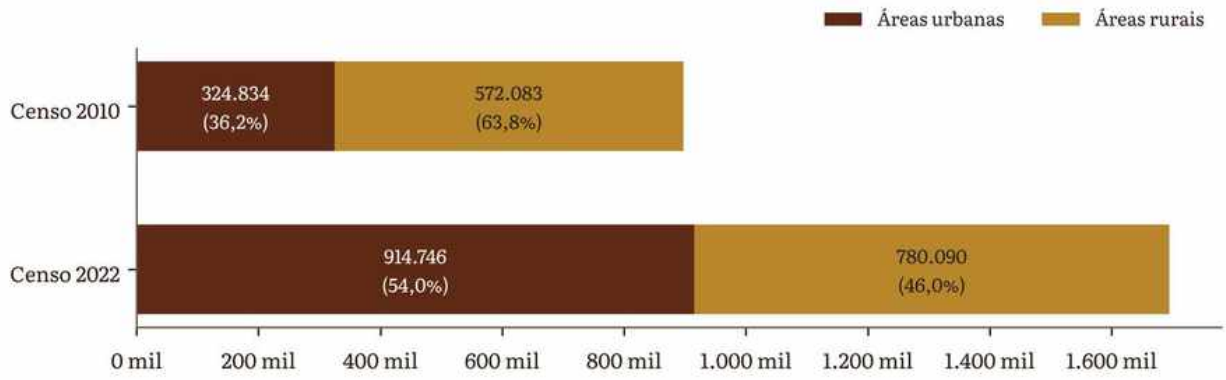
2 Diagnóstico em números

2.1 População e distribuição

O Censo Demográfico 2022 contou 1.694.836 pessoas indígenas, quase o dobro das 896.917 recenseadas em 2010. O IBGE atribui parte do aumento a melhorias metodológicas, entre elas a pergunta de pertencimento aplicada, nas localidades indígenas, a quem não se declarou indígena no quesito cor ou raça. O país tem 391 etnias e 295 línguas indígenas, mais que as 305 etnias e 274 línguas de 2010.

A mudança mais importante para a política de saúde é outra: a população indígena tornou-se majoritariamente urbana. Em 2022, 914.746 indígenas (53,97%) moravam em áreas urbanas, contra 324.834 (36,22%) em 2010, um crescimento de 181,6% em doze anos.

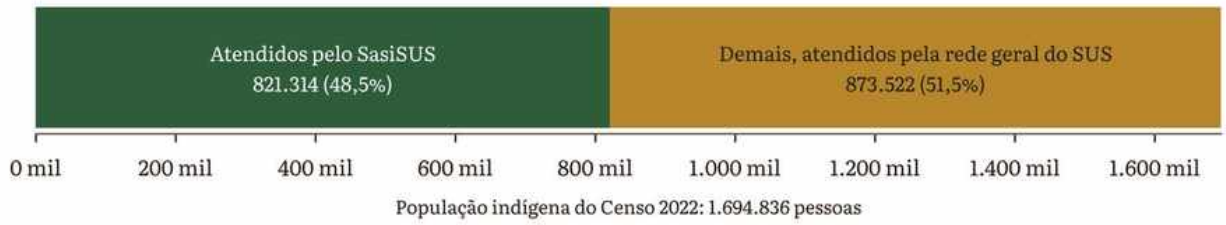
Figura 1. População indígena por situação do domicílio, Censos 2010 e 2022



Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 e 2022, divulgação de 19 de dezembro de 2024. Elaboração própria.

O Subsistema foi desenhado para o território. Sua unidade de organização é o Distrito, com Polos Base e Unidades Básicas dentro das aldeias. A consequência aparece na Figura 2: o número de pessoas atendidas pelo SasiSUS corresponde a menos da metade da população indígena recenseada.

Figura 2. População indígena recenseada e população atendida pelo SasiSUS



Fontes: IBGE, Censo 2022; Ministério da Saúde, balanço dos 27 anos do SasiSUS (setembro de 2026). O número do SasiSUS refere-se a pessoas atendidas registradas no SIASI e não é dado censitário; a comparação indica ordem de grandeza, não sobreposição exata.

2.2 Estrutura do Subsistema

34
Distritos Sanitários Especiais Indígenas

388
Polos Base

1.211
Unidades Básicas de Saúde Indígena

70
Casas de Apoio à Saúde Indígena

22 mil
trabalhadores, entre eles agentes indígenas de saúde e de saneamento

716
médicos nos territórios em 2025, ante 566 em 2024

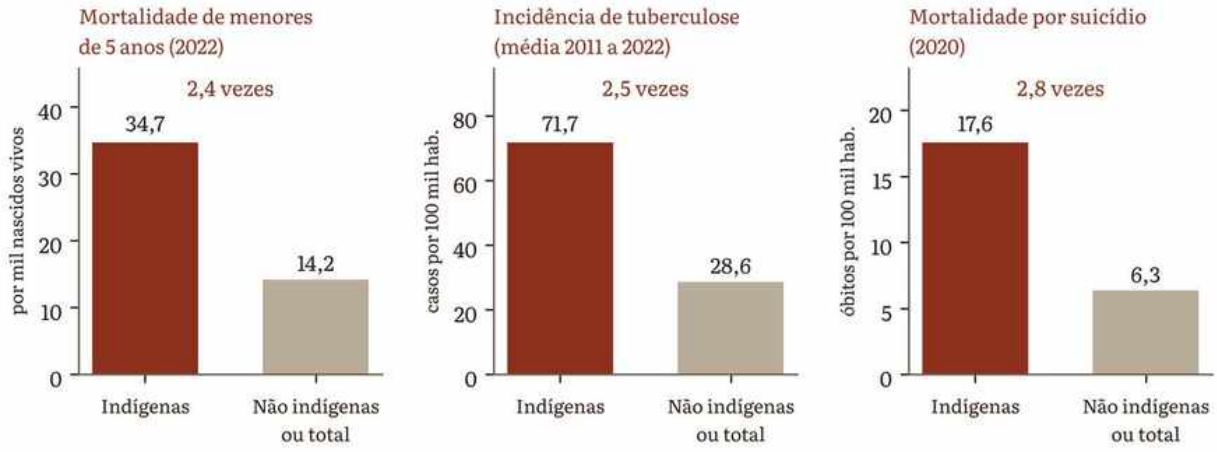
Fontes: Ministério da Saúde, SasiSUS 27 anos (setembro de 2026); SESAI, balanço de 2025 (dezembro de 2025).

Nos últimos dois anos o Subsistema ganhou instrumentos novos que este Plano aproveita: o primeiro SAMU Indígena, em Dourados (MS), que reduziu pela metade o tempo de espera por atendimento de urgência; o Comitê de Redução da Mortalidade Materna, Fetal e Infantil Indígena, criado em junho de 2026; a Política Nacional de Regulação em Saúde, com diretrizes próprias para a saúde indígena (Portaria GM/MS nº 9.262/2025); o reconhecimento dos especialistas das medicinas indígenas (Portaria GM/MS nº 10.676/2026); e a meta de conectar todas as unidades até o fim de 2026, que em abril de 2025 já contava com mais de 700 pontos instalados e telessaúde em 19 dos 34 Distritos.

2.3 Desigualdades nos indicadores de saúde

Os indicadores de mortalidade e de doenças transmissíveis mostram uma distância persistente entre indígenas e o restante da população. A Figura 3 resume três delas.

Figura 3. Indicadores selecionados de saúde: indígenas e não indígenas ou população total



Fontes: mortalidade de menores de 5 anos, Núcleo Ciência pela Infância (2024), com dados do SIM e do SINASC, comparação com crianças não indígenas; tuberculose, estudo publicado na Revista Brasileira de Epidemiologia (2023), com dados do SINAN de 2011 a 2022, comparação com não indígenas; suicídio, Cidacs/Fiocruz, The Lancet Regional Health Americas (2023), comparação com a população brasileira total.

Por trás das médias há padrões claros. Entre as crianças indígenas, as doenças respiratórias explicaram 18% dos óbitos e as infecciosas 14%, contra 7% e 6% entre as não indígenas: são mortes evitáveis com atenção primária, vacina, água limpa e remoção a tempo. A mortalidade neonatal indígena, de 12,4 por mil em 2022, ficou 55% acima da não indígena. No suicídio, a taxa registrada no próprio Subsistema foi de 17,2 por 100 mil habitantes em 2022, com os maiores valores no Centro-Oeste e no Norte.

Tabela 1. Síntese do quadro epidemiológico nacional

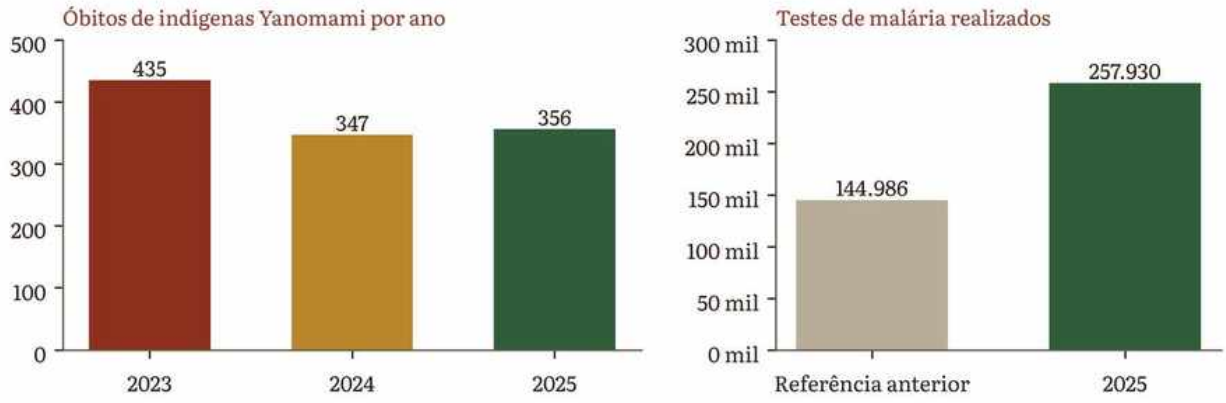
Indicador	Indígenas	Comparação	Razão	Período e fonte
Mortalidade de menores de 5 anos, por mil nascidos vivos	34,7	14,2	2,4	2022, NCPI com SIM e SINASC
Mortalidade neonatal, por mil nascidos vivos	12,4	cerca de 8,0	1,55	2022, NCPI
Óbitos infantis por doenças respiratórias	18%	7%	2,6	2018 a 2022, NCPI
Incidência de tuberculose, por 100 mil	71,7	28,6	2,5	média 2011 a 2022, Rev. Bras. Epidemiol.
Mortalidade por suicídio, por 100 mil	17,57	6,35	2,8	2020, Cidacs/Fiocruz
Mortalidade por suicídio no SasiSUS, por 100 mil	17,2	não se aplica		2022, SESAI

Nota: a mortalidade neonatal não indígena foi derivada da diferença de 55% informada pela fonte. Razões calculadas pelo autor. As fontes reconhecem subnotificação de óbitos e nascimentos em parte dos Distritos, de modo que as taxas indígenas tendem a estar subestimadas.

2.4 A resposta na Terra Indígena Yanomami

A resposta à emergência na Terra Indígena Yanomami mostrou o efeito de uma ação organizada com metas e acompanhamento. Com centro de operações, metas semanais, testagem em massa, presença permanente das equipes e apoio logístico das Forças Armadas, os óbitos caíram de 435 em 2023 para 347 em 2024 e 356 em 2025. Os óbitos por malária caíram 80,8% e a testagem para a doença passou de 144.986 para 257.930 exames. A auditoria do Tribunal de Contas da União registrou a queda das remoções aéreas por malária, de 109 para 40 por mês em média.

Figura 4. Terra Indígena Yanomami: óbitos anuais e testagem de malária



Fontes: Ministério da Saúde, Informes do COE Yanomami nº 8 (novembro de 2025) e nº 9 (abril de 2026); TCU, auditoria operacional. A estabilidade de 2024 para 2025 indica que o ganho inicial precisa de uma segunda etapa, centrada em atenção primária contínua e no fim das invasões.

A mesma auditoria apontou o limite do modelo: dados semestrais e pouco transparentes, que dificultam a comparação. O Plano incorpora as duas lições. Replica o método de sala de situação com metas e o torna permanente, e corrige a transparência com painel mensal e dados

abertos.

2.5 Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul tem a terceira maior população indígena do país, 116.469 pessoas, 4,22% dos habitantes do estado. Ali estão a Reserva Indígena de Dourados, com cerca de 16 mil moradores em 3.474 hectares, uma das maiores densidades populacionais indígenas do Brasil, e Campo Grande, onde o Censo 2022 contou cerca de 18,4 mil indígenas, a maior parte em aldeias urbanas e bairros periféricos. Em números absolutos, a capital sul-mato-grossense fica atrás de municípios amazônicos como Manaus (71,7 mil), mas se distingue por comunidades urbanas organizadas, com lideranças próprias, o que a torna o lugar ideal para o projeto piloto de atenção ao indígena na cidade. Os dados do Distrito de Mato Grosso do Sul, reunidos no Plano de Trabalho AgSUS/DSEI-MS 2026, mostram por que o estado deve ser prioridade.

Tabela 2. Distrito Sanitário Especial Indígena de Mato Grosso do Sul, 2025

Indicador	Valor	Leitura
População aldeada atendida	89.410	16 Polos Base, 78 aldeias regulares e mais de 71 áreas não homologadas
Óbitos por suicídio	35	39,1 por 100 mil, mais que o dobro da taxa nacional do Subsistema (17,2)
Tentativas e ideação suicida registradas	25 e 54	sinal de risco contínuo que exige vigilância ativa
Mortalidade infantil por causas evitáveis	27,55 por mil	meta pactuada de 8,64 por mil
Razão de mortalidade materna	125,23 por 100 mil	nível incompatível com o pré-natal disponível no território
Casos de tuberculose	111	124 por 100 mil, acima da média indígena nacional
Pessoas com hipertensão e com diabetes acompanhadas	5.442 e 3.017	6,1% e 3,4% da população atendida, em plena transição alimentar
Casos de doença diarreica aguda	3.970	marcador direto da falta de água e saneamento

Fonte: SIASI/SESAI 2025, conforme Plano de Trabalho Integrado AgSUS/DSEI-MS 2026, reproduzido na proposta técnica do CMDDI de Campo Grande (maio de 2026). Taxas por 100 mil e percentuais recalculados pelo autor sobre a população de 89.410 pessoas.

2.6 Problemas prioritários

Tabela 3. Problemas prioritários, evidências e consequências

Problema	Evidência	Consequência
Metade da população fora do Subsistema	914.746 indígenas urbanos; SasiSUS registra 821.314 atendidos	Indígenas na cidade atendidos sem intérprete, sem cuidado contínuo e sem registro étnico

Morte evitável de crianças	Mortalidade de menores de 5 anos 2,4 vezes maior; 32% dos óbitos infantis por causas respiratórias e infecciosas	Perda de vidas tratáveis com atenção primária, vacina e remoção oportuna
Sofrimento mental sem rede	Suicídio 2,8 vezes maior; 39,1 por 100 mil no DSEI-MS	Mortes de jovens e desagregação comunitária
Dados lentos e opacos	Dados semestrais e de difícil comparação, segundo o TCU; subnotificação reconhecida pelas fontes	Gestão sem bússola e cobrança impossível
Rotatividade e vazios de profissionais	716 médicos para 34 Distritos; dependência de contratos temporários	Quebra do vínculo e do acompanhamento
Orçamento instável	Proposta de R$ 3,79 bilhões no PLOA 2025 com corte parlamentar de R$ 1,6 bilhão, depois recomposto	Incerteza que paralisa contratos e obras
Atividade econômica sem avaliação de saúde	Garimpo ilegal associado a malária, desnutrição e contaminação por mercúrio	Crise sanitária que custa vidas e recursos muito maiores que a prevenção

Fontes: as citadas nas seções anteriores; orçamento, declarações do Ministro da Saúde e relatório do Inesc sobre o PLOA 2025.

3 Fundamentos jurídicos e salvaguardas

O Plano não depende de reforma constitucional nem de lei nova para começar. Ele organiza e cobra o cumprimento de deveres que a ordem jurídica já impõe à União. Este capítulo mostra a base de cada medida e as salvaguardas que tornam o Plano resistente a questionamentos judiciais e à troca de gestores.

3.1 O instrumento: decreto presidencial

O art. 84, VI, "a", da Constituição autoriza o Presidente da República a dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando isso não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos. É o caso de um plano que coordena ministérios, institui um comitê sem cargos novos, fixa metas e determina a publicação de dados. O decreto proposto no Anexo A respeita esses limites. As medidas que dependem de lei, como a explicitação da cobertura dos indígenas urbanos e a proteção orçamentária permanente, estão separadas e acompanhadas de minuta (Anexo B).

3.2 O direito à saúde diferenciada, onde quer que o indígena esteja

A combinação dos arts. 196 e 231 da Constituição com os arts. 19-A a 19-H da Lei nº 8.080/1990 garante aos povos indígenas atenção diferenciada, que respeite sua organização social, línguas e práticas. O art. 19-A refere-se às populações indígenas "em todo o território nacional", sem condicionar o atendimento à residência em terra homologada. A Convenção nº 169 da OIT, cuja promulgação consta hoje do Decreto nº 10.088/2019, determina no art. 25 que os serviços de saúde sejam planejados e administrados em cooperação com os povos interessados.

O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 709, determinou em 2020 a extensão do Subsistema aos indígenas não aldeados e aos residentes em terras não homologadas. Em Mato Grosso do Sul, a Ação Civil Pública nº 5004426-89.2020.4.03.6000, na 2ª Vara Federal de Campo Grande, obteve liminares no mesmo sentido para os indígenas urbanos de nove municípios, mantidas por decisão de 19 de setembro de 2024 que rejeitou a tese de que a SESAI só atenderia esse público em caráter excepcional. O eixo 5 deste Plano dá cumprimento estruturado a essas decisões, o que reduz o risco de multas e de responsabilização de gestores.

3.3 Autonomia econômica e seus limites constitucionais

O direito dos povos indígenas de decidir sobre as atividades produtivas em suas terras encontra apoio no direito de autodeterminação reconhecido pela Convenção nº 169 (art. 7º), que garante a esses povos o direito de definir suas próprias prioridades de desenvolvimento. A Constituição estabelece as condições: as terras indígenas são de usufruto exclusivo de seus ocupantes (art. 231, § 2º), e o aproveitamento de recursos hídricos e a lavra de riquezas minerais nelas só podem ocorrer com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas (art. 231, § 3º). A Convenção exige consulta prévia, livre e informada sempre que medidas administrativas ou legislativas possam afetá-las (art. 6º).

O Plano transforma esses limites em procedimento de saúde. Toda atividade produtiva autorizada em terra indígena passa a exigir Avaliação de Impacto em Saúde, com linha de base sanitária, monitoramento e plano de mitigação (eixo 10). Assim, a decisão é da comunidade, a autorização segue a Constituição e a saúde é protegida antes que o dano ocorra.

3.4 Dados de saúde, privacidade e soberania de dados

Dados de saúde e de origem étnica são dados pessoais sensíveis (Lei nº 13.709/2018, arts. 5º, II, e 11), e seu tratamento pela administração pública é permitido para execução de políticas públicas e tutela da saúde, com salvaguardas. O Plano adota quatro regras: finalidade exclusivamente assistencial e de vigilância; acesso por perfil e registro de cada consulta ao prontuário; publicação apenas de dados agregados que não permitam identificar pessoas ou pequenas comunidades; e uso para pesquisa somente com aprovação ética e anuência das comunidades, como exige a Resolução CNS nº 304/2000.

3.5 Medicinas indígenas e conhecimentos tradicionais

A Portaria GM/MS nº 10.676/2026 reconheceu os especialistas das medicinas indígenas no âmbito da PNASPI e do Subsistema. A Lei nº 13.123/2015 protege o conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético e exige consentimento prévio informado e repartição de benefícios em caso de uso econômico. O eixo 9 articula as duas normas: valoriza rezadores, parteiras e pajés no cuidado e impede a apropriação indevida desses saberes.

Tabela 4. Base normativa do Plano

Norma	O que assegura ao Plano	Eixos
Constituição, arts. 196, 198, 231 e 232	Saúde como direito; organização social e usufruto indígenas; legitimidade dos povos para defender seus direitos	Todos
Constituição, art. 84, IV e VI, "a"	Decreto de organização da administração federal sem aumento de despesa	11
Lei nº 8.080/1990, arts. 19-A a 19-H (Lei nº 9.836/1999), e Decreto nº 3.156/1999	Subsistema financiado pela União; atenção diferenciada; participação indígena no controle social	Todos
Convenção nº 169 da OIT (Decreto nº 10.088/2019)	Consulta prévia; prioridades próprias de desenvolvimento; serviços de saúde em cooperação com os povos	5, 9, 10
ADPF 709 e ACP nº 5004426-89.2020.4.03.6000	Extensão do Subsistema a indígenas não aldeados e urbanos	5
Lei nº 13.958/2019 e Lei nº 14.621/2023	Agência de apoio à gestão do SUS, hoje AgSUS, com contratação e carreira para a atenção primária	7
Lei nº 14.510/2022	Telessaúde em todo o território nacional	6
Leis nº 14.129/2021 e nº 13.709/2018 (LGPD)	Governo digital e dados abertos; tratamento de dados sensíveis de saúde e etnia	6, 11
Lei nº 13.123/2015	Proteção do conhecimento tradicional associado	9
Portarias GM/MS nº 9.262/2025 e nº 10.676/2026	Regulação com diretrizes indígenas; reconhecimento dos especialistas das medicinas indígenas	7, 9
LC nº 101/2000, art. 9º, § 2º; LC nº 200/2023	Despesas ressalvadas do contingenciamento; regime fiscal sustentável	11

4 Alinhamento com o programa de governo

O programa de governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva para 2027 a 2030, registrado no TSE com o título *Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil: um país soberano, democrático, desenvolvido, sustentável e criativo*, organiza-se em 13 diretrizes. Na saúde, prevê a continuidade e a ampliação do Mais Médicos, do Agora Tem Especialistas e da Farmácia Popular, o fortalecimento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde e a digitalização dos serviços do SUS. Para os povos indígenas, compromete-se com a atenção diferenciada à saúde, com a proteção dos territórios e com a continuidade das demarcações e das desintrusões. Este Plano dá a esses compromissos forma executável no Subsistema, com metas, prazos e responsáveis.

Tabela 5. Correspondência entre o programa de governo e o Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas

Programa ou compromisso	Como se traduz na saúde indígena	Eixo
Atenção diferenciada à saúde indígena	Subsistema com acordos de resultados nos 34 Distritos, painel mensal e atenção aos indígenas que vivem nas cidades	Todos
Mais Médicos (Lei nº 14.621/2023)	Vagas específicas nos territórios, provimento estável e formação em saúde indígena para os profissionais	7
Agora Tem Especialistas	Fila indígena acompanhada nominalmente, mutirões de consultas, exames e cirurgias e uso da rede credenciada nas regiões com maior espera, com protocolo de acolhimento indígena	7
SUS Digital e Meu SUS Digital	Prontuário indígena integrado à RNDS, com identificação étnica e funcionamento sem internet; todas as 1.211 UBSI conectadas; telessaúde nos 34 Distritos	6
Farmácia Popular e assistência farmacêutica	Entrega de medicamentos de uso contínuo na aldeia e tratamento supervisionado da tuberculose	2, 4
Complexo Econômico-Industrial da Saúde	Vacinas e insumos de produção nacional; cadeia de frio solar para manter as vacinas no território	1, 2
Novo PAC Saúde e saneamento	Construção e reforma de UBSI e CASAI e abastecimento de água nas aldeias	8
Proteção territorial e desintrusão	Saúde integrada às operações contra o garimpo ilegal, com vigilância do mercúrio e apoio logístico das Forças Armadas	2, 10
Participação social e controle democrático	Conselhos Distritais fortalecidos, painel público e prestação de contas anual às comunidades	11

Fontes: programa de governo registrado no TSE e índice publicado pelo Tribunal; cobertura do documento por Exame, Congresso em Foco e Mais Goiás (2026). A redação resume o conteúdo publicado e não substitui o texto oficial.

4.1 Políticas federais em vigor que o Plano aproveita

O Plano parte de políticas e instrumentos que estão em funcionamento. Usá-los reduz o custo de implantação e aproveita a experiência das equipes do Ministério da Saúde, da SESAI e dos Distritos.

Tabela 6. Políticas e instrumentos em vigor que o Plano aproveita

Instrumento	O que estabelece	Uso no Plano
Lei nº 14.621, de 14 de julho de 2023	Retomada e reestruturação do Programa Mais Médicos, com estratégias de provimento em áreas remotas	Provimento e fixação de médicos nos Distritos (eixo 7)
Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS)	Contrato de gestão com o Ministério da Saúde para a contratação de profissionais da saúde indígena (Contrato de Gestão nº 02/2024)	Contratação estável e com metas nos Distritos (eixo 7)
Lei nº 14.510, de 27 de dezembro de 2022	Telessaúde permanente em todo o território nacional, incorporada à Lei nº 8.080/1990	Base legal da telessaúde indígena (eixo 6)
Programa SUS Digital e Rede Nacional de Dados em Saúde	Transformação digital do SUS, interoperabilidade dos dados e acesso do cidadão ao próprio histórico de saúde	Prontuário indígena integrado à RNDS (eixo 6)
Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021	Princípios do governo digital, dados abertos e interoperabilidade	Painel mensal e dados abertos (eixo 11)
Encerramento da ADPF 709 (setembro de 2025)	Critérios técnicos para o público atendido e para a distribuição de recursos entre os Distritos a partir de 2027	Orçamento por necessidade (capítulo 9)

Fontes: textos oficiais das normas; Ministério da Saúde; Supremo Tribunal Federal.

4.2 A resposta à emergência Yanomami

Em janeiro de 2023, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional na Terra Indígena Yanomami. A resposta combinou a retirada do garimpo ilegal, a reabertura de polos base, a recomposição das equipes, o apoio logístico das Forças Armadas e o reforço do Mais Médicos. Relatório situacional apresentado pela SESAI à Comissão Intergestores Tripartite em maio de 2026 registra queda de 18,2% no total de óbitos entre 2023 e 2025, de 435 para 356, com redução de 80,8% nos óbitos por malária, de 53,2% nos óbitos por desnutrição e de 16,7% nos óbitos por infecções respiratórias agudas.

> ### Implicações para o Plano
>
> A experiência Yanomami mostra que a saúde indígena melhora quando a resposta sanitária vem junto com a proteção do território, a presença contínua das equipes e o acompanhamento de indicadores. O Plano aplica esse modelo de forma permanente nos 34 Distritos, com sala de situação, metas públicas e prioridade para as áreas mais afetadas (eixos 2, 7 e 10).

Fontes: Ministério da Saúde, SESAI, relatório situacional à Comissão Intergestores Tripartite (maio de 2026), publicado pelo Conass. Os dados são do próprio governo e serão acompanhados no painel do Plano.

4.3 As propostas de saúde do programa de governo

O programa de governo trata a saúde como direito e prevê a ampliação do acesso à atenção especializada pelo Agora Tem Especialistas, a manutenção do Mais Médicos, a ampliação da Farmácia Popular, o fortalecimento da produção nacional de medicamentos, vacinas e equipamentos e a continuidade da transformação digital do SUS. Também assume compromisso com a atenção diferenciada à saúde indígena.

Cada uma dessas propostas tem tradução direta para os povos indígenas, como mostra a Tabela 5, e quatro delas ganham força especial no Subsistema. O prontuário integrado resolve a perda de informação quando o paciente indígena sai da aldeia para a cidade. A telessaúde leva o especialista aonde ele nunca chegaria. O Agora Tem Especialistas, com fila nominal e mutirões, reduz o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias. E o Mais Médicos, com vagas próprias nos territórios, completa as equipes multidisciplinares.

Fontes: programa de governo registrado no TSE; Exame, "Plano de governo de Lula: o que o petista propõe para um 4º mandato" (2026); Congresso em Foco, íntegra do programa (2026).

A AgSUS na saúde indígena

A AgSUS executa hoje o contrato de gestão da saúde indígena com o Ministério da Saúde (Contrato de Gestão nº 02/2024), com contratação por CLT e carreira. O Plano utiliza esse instrumento, já em funcionamento, para contratar e fixar profissionais nos territórios com metas de desempenho.

5 Arquitetura do Plano

Missão

Garantir que cada pessoa indígena, na aldeia ou na cidade, tenha atenção à saúde contínua, resolutiva e respeitosa de sua cultura, com resultados medidos e públicos.

Visão para 2030

Um Subsistema que reduziu a desigualdade de mortalidade infantil, que sabe em tempo real onde estão seus pacientes e seus profissionais e que presta contas todos os meses.

5.1 Princípios

Gasto vinculado a resultado

Todo gasto novo deve estar associado a meta e indicador.

Usar o que existe

34 Distritos, AgSUS, SUS Digital, SAMU e Mais Médicos, sem estrutura nova.

Diferença com igualdade

Cuidado adaptado à cultura e à língua, com o mesmo padrão de qualidade do SUS.

Decisão indígena

Controle social dos CONDISI e consulta prévia nas decisões que afetam os povos.

Dados abertos

Painel mensal por Distrito, com proteção de dados pessoais.

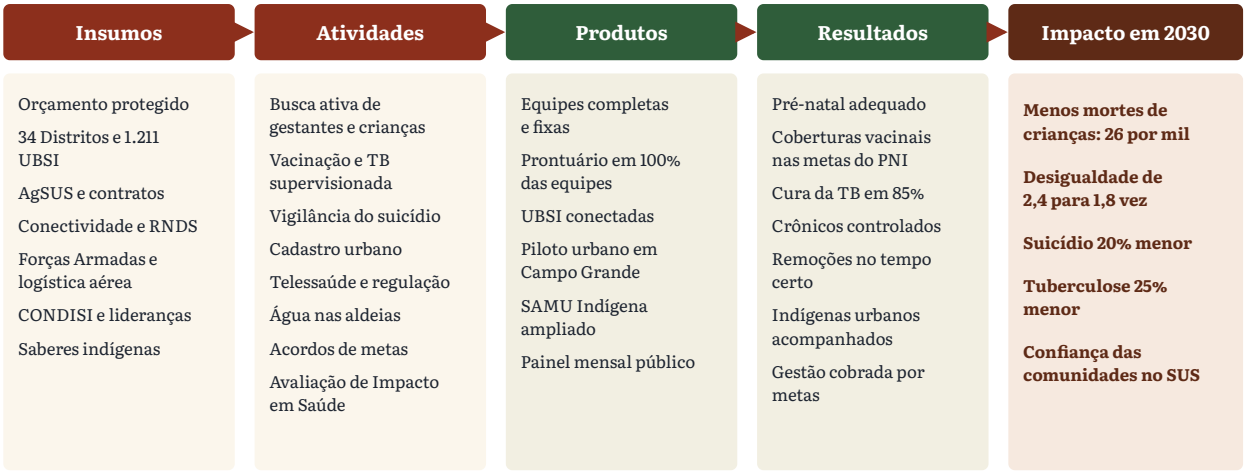
Responsabilidade fiscal

Execução dentro do regime fiscal, com proteção contra cortes nas ações essenciais.

5.2 Modelo lógico

O modelo lógico explicita a cadeia de causa e efeito que o Plano pretende produzir e que o monitoramento vai testar.

Figura 5. Modelo lógico do Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas



Elaboração própria.

6 Os onze eixos de execução

Cada eixo tem objetivo, ações, metas e responsáveis. As metas são numeradas de M1 a M31 e reunidas no painel do capítulo 7, com linha de base, valores intermediários e fonte de verificação.

Eixo 1. Primeira infância e maternidade segura

Objetivo. Reduzir as mortes evitáveis de gestantes, recém-nascidos e crianças, que concentram a maior desigualdade entre indígenas e não indígenas.

1. Busca ativa mensal de todas as gestantes e crianças menores de cinco anos de cada aldeia, com lista nominal no prontuário e alerta automático de consulta atrasada.
2. Protocolo de sinais de alarme para infecção respiratória e diarreia na criança, com antibiótico e reidratação disponíveis na UBSI e critérios de remoção imediata.
3. Plano de parto para toda gestante, com transporte garantido e acolhimento na CASAI nas semanas finais quando a aldeia for distante.
4. Integração das parteiras tradicionais às equipes, com formação conjunta e kit de parto limpo.
5. Comitês distritais de investigação de óbito materno, fetal e infantil ligados ao Comitê Nacional criado em junho de 2026, com análise de cada óbito em até 60 dias.
6. Vigilância alimentar e nutricional de todas as crianças, com suplementação e articulação com programas de transferência de renda.

> **Metas:** M1 mortalidade de menores de 5 anos de 34,7 para no máximo 26 por mil nascidos vivos; M2 razão entre mortalidade indígena e não indígena de 2,4 para no máximo 1,8; M3 mortalidade neonatal de 12,4 para no máximo 9,5 por mil; M4 80% das gestantes com seis ou mais consultas de pré-natal.

Responsáveis: SESAI e Distritos; Secretaria de Atenção Primária; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Eixo 2. Doenças transmissíveis e vacinas

Objetivo. Interromper a transmissão de tuberculose, malária e sífilis e manter as coberturas vacinais nas metas do PNI em todos os Distritos.

1. Tratamento diretamente observado da tuberculose na aldeia, feito pelo agente indígena de saúde, com entrega domiciliar do medicamento e busca dos contatos.
2. Diagnóstico molecular rápido da tuberculose em todos os Polos Base de Distritos com incidência acima da média.
3. Extensão do modelo do COE Yanomami às demais áreas de malária: testagem ampla, tratamento no mesmo dia e controle vetorial, com apoio aéreo quando necessário.

4. Teste rápido de sífilis e HIV em todo pré-natal, com tratamento da gestante e da parceria na própria UBSI.
5. Cadeia de frio com refrigeradores solares nas UBSI sem energia estável e microplanejamento de vacinação por aldeia.
6. Operação Gota, com equipes volantes de vacinação em áreas de difícil acesso, integrada à logística das Forças Armadas.

> **Metas:** M5 incidência de tuberculose 25% menor que a linha de base de 71,7 por 100 mil; M6 cura de 85% dos casos novos; M7 zero óbito evitável por malária na Terra Yanomami e nas demais áreas endêmicas monitoradas; M8 coberturas vacinais infantis nas metas do PNI nos 34 Distritos.

Responsáveis: SESAI; Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente; Ministério da Defesa.

Eixo 3. Bem viver e saúde mental

Objetivo. Reduzir o suicídio e o sofrimento mental com uma rede que una a vigilância ativa, a atenção psicossocial e o cuidado tradicional das próprias comunidades.

1. Vigilância ativa de ideação, tentativa e óbito por suicídio, com acompanhamento de toda pessoa que tentou suicídio em até 72 horas e por pelo menos seis meses.
2. Psicólogo e assistente social em todos os Distritos, com reforço proporcional à taxa de suicídio, a começar por Mato Grosso do Sul.
3. Pactuação com a Rede de Atenção Psicossocial dos municípios de referência, com vagas e protocolo de acolhimento indígena nos CAPS.
4. Rodas de bem viver conduzidas por rezadores, lideranças e jovens indígenas, com apoio das equipes, nos territórios de maior risco.
5. Prevenção do uso nocivo de álcool e de outras drogas, com ações construídas com as lideranças e articuladas à segurança pública no combate ao tráfico nas aldeias.
6. Atenção às mulheres e crianças em situação de violência, com rede de proteção pactuada com delegacias, conselhos tutelares e Ministério Público.

> **Metas:** M9 mortalidade por suicídio no SasiSUS de 17,2 para no máximo 13,8 por 100 mil; M10 no Distrito de Mato Grosso do Sul, de 39,1 para no máximo 27 por 100 mil; M11 100% das pessoas com tentativa de suicídio acompanhadas em até 72 horas.

Responsáveis: SESAI e Distritos; Secretaria de Atenção Especializada; Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Eixo 4. Doenças crônicas, alimentação e segurança alimentar

Objetivo. Responder à transição alimentar e ao crescimento da hipertensão e do diabetes, que já atingem milhares de pessoas acompanhadas nos Distritos.

1. Rastreamento anual de pressão arterial e glicemia em adultos, com registro no prontuário e lista nominal de pessoas com hipertensão e diabetes.

2. Entrega domiciliar dos medicamentos de uso contínuo na aldeia, com dispensação trimestral quando houver estabilidade clínica.
3. Rastreamento do câncer do colo do útero com teste molecular para HPV, com coleta na UBSI.
4. Apoio às roças, à pesca e à produção de alimentos tradicionais, articulado ao Programa de Aquisição de Alimentos e à alimentação escolar indígena.
5. Educação alimentar construída com as comunidades para reduzir o consumo de ultraprocessados e bebidas açucaradas.

> **Metas:** M12 70% das pessoas com hipertensão e diabetes com controle registrado a cada semestre; M13 redução de 20% da desnutrição crônica em menores de 5 anos sobre a linha de base de 2027; M14 entrega domiciliar de medicamentos contínuos implantada nos 34 Distritos.

Responsáveis: SESAI; Ministério do Desenvolvimento Agrário; Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social; Ministério da Educação.

Eixo 5. Saúde indígena na cidade

Objetivo. Levar atenção diferenciada aos 914.746 indígenas que vivem em áreas urbanas, em cumprimento à Lei nº 9.836/1999 e às decisões judiciais, sem duplicar o SUS municipal.

Este eixo incorpora a proposta técnica elaborada por caciques, comunidades e pelo CMDDI de Campo Grande, aprovada por aclamação em plenária extraordinária do Conselho em 29 de maio de 2026. A proposta desenha um Distrito urbano em Campo Grande, com coordenação própria, centro de referência, quatro equipes multidisciplinares urbanas na capital e quatro nos municípios prioritários, conselho distrital urbano e escritório regional da AgSUS, num total de 151 profissionais. O custo estimado é de R$ 46,1 milhões por ano, menos de 2% do orçamento atual da SESAI, para uma população de 26 a 33 mil indígenas urbanos em Mato Grosso do Sul.

1. Projeto piloto em Campo Grande e nos nove municípios abrangidos pela ação civil pública, conforme a proposta do CMDDI, instituído por portaria em até 100 dias e com cadastro dos indígenas urbanos iniciado no primeiro semestre de 2027.
2. Módulo urbano do SIASI e preenchimento obrigatório de etnia e língua no e-SUS APS, para que o indígena na cidade deixe de ser invisível nos dados.
3. Equipes multidisciplinares urbanas com agentes de interlocução cultural, que realizam atendimento nas aldeias urbanas e nos bairros onde vivem as famílias indígenas.
4. Intérpretes e mediadores culturais nas unidades de referência, com espaço para rezadores e parteiras.
5. Termos de cooperação com os municípios, sem retirar recursos municipais: o SUS municipal continua responsável pela urgência e pela atenção especializada, e a União financia a camada diferenciada, como determina o art. 19-C da Lei nº 8.080/1990.

6. Expansão, a partir de 2029, para as regiões metropolitanas com maior população indígena urbana segundo o Censo 2022, depois da avaliação do piloto.

> **Metas:** M15 piloto de Campo Grande implantado em 2027, com 80% dos indígenas urbanos cadastrados acompanhados em 24 meses; M16 etnia preenchida em 95% dos registros de pessoas indígenas na APS; M17 atenção diferenciada urbana funcionando em cinco regiões metropolitanas até 2030.

Responsáveis: SESAI; AgSUS; Secretaria de Atenção Primária; municípios por adesão; CMDDI e conselhos indígenas locais.

Eixo 6. Saúde Digital Indígena

Objetivo. Fazer do Subsistema o primeiro segmento do SUS com registro eletrônico completo, conectividade universal e telessaúde em todo o território.

1. Conclusão da conectividade das 1.211 UBSI, com redundância por satélite nas unidades remotas e energia solar onde não houver rede elétrica.
2. Prontuário eletrônico indígena integrado à RNDS, cumprindo para os povos indígenas a visão da Estratégia de Saúde Digital 2020 a 2028, que funcione sem internet e sincronize quando houver sinal, com campos para etnia, língua, aldeia e práticas tradicionais relevantes ao cuidado.
3. Telessaúde especializada nos 34 Distritos, com prioridade para pediatria, obstetrícia, psiquiatria, dermatologia e infectologia, e telediagnóstico de eletrocardiograma e imagem.
4. Central de regulação indígena com apoio de inteligência artificial para classificar a urgência das remoções e prever a ocupação das CASAI, sempre com decisão final de um profissional.
5. Rastreamento em tempo real das remoções aéreas e terrestres, para reduzir tempo de resposta e custo das horas de voo.

> **Metas:** M18 100% das UBSI conectadas; M19 telessaúde especializada nos 34 Distritos, partindo de 19; M20 prontuário eletrônico integrado à RNDS em 100% das equipes.

Responsáveis: SESAI; Secretaria de Informação e Saúde Digital; Ministério das Comunicações; Telebras.

Eixo 7. Profissionais, urgência e acesso a especialistas

Objetivo. Ter equipes completas e estáveis no território e garantir que o paciente indígena chegue ao especialista e à urgência no tempo certo.

1. Contratação e fixação de médicos, enfermeiros e dentistas pela AgSUS, com adicional por área remota, escala que permita descanso e plano de carreira.

2. Formação técnica de nível médio para agentes indígenas de saúde e de saneamento, com certificação reconhecida e prioridade para jovens indígenas.
3. Programa Nacional de Técnicos de Enfermagem Indígenas, em parceria entre a SESAI, os Distritos, as escolas estaduais de saúde pública e as escolas técnicas do SUS, com turmas formadas por indígenas das próprias comunidades, aulas próximas das aldeias e estágio nas unidades do Distrito, a partir da experiência de Mato Grosso do Sul.
4. Bolsas e vagas para estudantes indígenas em medicina, enfermagem e odontologia, com compromisso de atuação nos Distritos de origem.
5. Ampliação do SAMU Indígena, a partir da experiência de Dourados, para os Distritos com maior demanda de urgência.
6. Mutirões e uso da rede credenciada, no âmbito do programa Agora Tem Especialistas, para consultas, exames e cirurgias eletivas nas regiões com fila, pagos por produção e com protocolo de acolhimento indígena.
7. Apoio dos hospitais militares e do Programa Calha Norte nas regiões de fronteira, com integração à regulação indígena.

Metas: M21 no mínimo 1.000 médicos em atuação nos territórios, partindo de 716; M22 50% dos agentes indígenas de saúde e de saneamento com formação técnica concluída e turmas de técnicos de enfermagem indígenas nos 34 Distritos; M23 SAMU Indígena em pelo menos cinco Distritos; M24 redução de 30% no tempo entre a indicação e a realização da consulta especializada.

Responsáveis: SESAI; AgSUS; Secretaria de Atenção Especializada; Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde; escolas técnicas do SUS; Ministério da Educação; Ministério da Defesa.

Casos de referência: profissionais de enfermagem indígenas

Mato Grosso do Sul tem experiências que mostram o valor de formar profissionais nas próprias comunidades. Em Dourados, um curso técnico de enfermagem formou jovens indígenas das aldeias Jaguapiru e Bororó; muitos dos egressos, bilíngues em português e guarani, compõem hoje a equipe do SAMU Indígena, implantado em agosto de 2025. A parceria da saúde indígena com a escola de saúde pública do estado formou turma de técnicos de enfermagem composta exclusivamente por indígenas das próprias comunidades, experiência acompanhada pelas lideranças do FOCAMS. A Escola Técnica do SUS do estado também qualificou, entre 2019 e 2022, 215 agentes indígenas de saúde e de saneamento, com o Distrito Sanitário e a UFGD. Em Mato Grosso, o curso de Enfermagem Intercultural Indígena da Unemat, iniciado em 2023 com turma de povos de todo o estado, foi reconhecido em audiência da Comissão de Educação do Senado em junho de 2026, que recomendou sua replicação e a parceria com a Universidade Federal Indígena.

Tabela 7. Experiências de formação de profissionais indígenas de enfermagem e saúde

Experiência	O que mostrou	Uso no Plano
Técnicos de enfermagem indígenas de Dourados (MS)	Jovens das aldeias Jaguapiru e Bororó formados como técnicos; egressos bilíngues atuam no SAMU Indígena desde 2025	Modelo para turmas nas aldeias e para a expansão do SAMU Indígena (M22, M23)
Escola de saúde pública e Escola Técnica do SUS (MS)	Turma de técnicos de enfermagem só com indígenas das comunidades; 215 agentes indígenas qualificados entre 2019 e 2022	Parceria com a rede de escolas técnicas do SUS em todos os Distritos
Enfermagem Intercultural Indígena da Unemat (MT)	Graduação intercultural desde 2023, reconhecida pelo Senado em 2026 como experiência a replicar	Bolsas e vagas de graduação em enfermagem e parceria com a Universidade Federal Indígena

Fontes: Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso do Sul, acordo que garantiu o registro profissional de jovens enfermeiros indígenas de Dourados; Instituto Presbiteriano Mackenzie, "SAMU Indígena conta com participação de egressos da Escola Vital Brasil" (dezembro de 2025); Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (2023); Agência Senado, "Curso de enfermagem indígena recebe reconhecimento na Comissão de Educação" (11 de junho de 2026); relato das lideranças do FOCAMS.

Eixo 8. Água, saneamento e moradia saudável

Objetivo. Atacar a causa das doenças diarreicas e de parte das infecções que ainda matam crianças indígenas.

1. Diagnóstico completo de abastecimento de água em todas as aldeias em 2027, com dados abertos, para fixar a linha de base que hoje não existe de forma confiável.
2. Execução do programa de saneamento indígena de R$ 10,85 bilhões em 20 anos, que prevê R$ 187 milhões em 2026, com priorização pelas aldeias de maior incidência de diarreia infantil.
3. Sistemas simplificados de captação, tratamento e distribuição de água, com operação e manutenção a cargo dos agentes indígenas de saneamento.
4. Monitoramento mensal da qualidade da água e manejo de resíduos sólidos nas aldeias de maior densidade, como a Reserva de Dourados.

> **Metas:** M25 aumento de 20 pontos percentuais na proporção de aldeias com água tratada sobre a linha de base de 2027; M26 redução de 30% na incidência de doença diarreica aguda em menores de 5 anos.

Responsáveis: SESAI e Distritos; Ministério das Cidades; agentes indígenas de saneamento.

Eixo 9. Medicinas indígenas e conhecimentos tradicionais

Objetivo. Integrar rezadores, pajés e parteiras ao cuidado, com reconhecimento e proteção jurídica dos saberes.

1. Implantação da Portaria GM/MS nº 10.676/2026 em todos os Distritos, com cadastro voluntário dos especialistas das medicinas indígenas indicados pelas comunidades.

2. Protocolos de cuidado compartilhado entre especialistas tradicionais e equipes de saúde, construídos em cada Distrito.
3. Regras de proteção do conhecimento tradicional nos registros de saúde, conforme a Lei nº 13.123/2015, sem divulgação de práticas sem consentimento.
4. Apoio a iniciativas comunitárias de documentação e proteção desses saberes, como o Programa Saberes Originários proposto pelo ICET, CMDDI e FOCAMS em Mato Grosso do Sul.

> **Meta:** M27 especialistas das medicinas indígenas reconhecidos e atuando em cuidado compartilhado nos 34 Distritos.

Responsáveis: SESAI; Ministério da Cultura; instituições de ensino e pesquisa.

Eixo 10. Território, produção e saúde

Objetivo. Garantir que a autonomia econômica indígena venha acompanhada de proteção à saúde, e que a atividade ilegal seja enfrentada também como problema sanitário.

1. Avaliação de Impacto em Saúde obrigatória para toda atividade produtiva autorizada em terra indígena, com linha de base sanitária, indicadores de monitoramento e plano de mitigação custeado pelo empreendimento.
2. Monitoramento de mercúrio em pessoas e peixes nas áreas afetadas pelo garimpo, com protocolo de cuidado para gestantes e crianças.
3. Saúde do trabalhador indígena na agricultura e no extrativismo, com prevenção de intoxicação por agrotóxicos.
4. Integração das equipes de saúde às operações de desintrusão e de controle de fronteiras, com retorno das equipes ao território em até 72 horas após cada operação.

> **Meta:** M28 100% das atividades produtivas autorizadas em terras indígenas com Avaliação de Impacto em Saúde e monitoramento ativo.

Responsáveis: SESAI; Ministério da Defesa; Polícia Federal; órgãos ambientais; Ministério de Minas e Energia.

Eixo 11. Gestão, integridade e transparência

Objetivo. Cobrar resultado de cada Distrito, combater desperdício e desvio, e dar ao cidadão acesso aos números.

1. Acordo de resultados anual entre a SESAI e cada um dos 34 Distritos, com as metas deste Plano desdobradas e avaliação trimestral, inspirado no pagamento por desempenho do Previne Brasil.
2. Contratos e convênios com entidades e com a AgSUS vinculados a metas, com parcela do repasse condicionada ao desempenho.

3. Compras centralizadas de medicamentos, insumos e horas de voo, com preço de referência público.
4. Painel mensal público dos 34 Distritos, com dados abertos agregados, e sala de situação presidencial a cada trimestre.
5. Auditoria permanente em parceria com a Controladoria-Geral da União e canal de denúncia protegido para profissionais e usuários.
6. Fortalecimento dos CONDISI, com capacitação de conselheiros e acesso ao painel antes de cada reunião.
7. Qualificação dos dados vitais: relacionamento anual das bases do SIASI, do SIM e do SINASC e busca ativa de óbitos e nascimentos não registrados, para corrigir a subnotificação reconhecida pelas fontes.

> **Metas:** M29 painel mensal publicado para os 34 Distritos; M30 100% dos contratos e convênios com metas e pagamento vinculado a desempenho; M31 execução de pelo menos 95% da dotação anual das ações essenciais.

Responsáveis: Casa Civil; SESAI; AgSUS; Controladoria-Geral da União.

7 Painel de metas e indicadores

O painel reúne as 31 metas do Plano. Onde não há linha de base confiável, a meta de 2027 é medi-la, e as metas relativas passam a valer sobre esse valor. Essa escolha evita a prática comum de fixar metas sobre números que ninguém sabe se são verdadeiros.

Tabela 8. Painel de metas, linha de base e trajetória

Nº	Indicador	Linha de base	2028	2030	Verificação
Eixo 1. Primeira infância e maternidade segura					
M1	Mortalidade de menores de 5 anos, por mil nascidos vivos	34,7 (2022)	30,3	até 26,0	SIM, SINASC, SIASI
M2	Razão de mortalidade de menores de 5 anos, indígenas sobre não indígenas	2,4 (2022)	2,1	até 1,8	SIM, SINASC
M3	Mortalidade neonatal, por mil nascidos vivos	12,4 (2022)	11,0	até 9,5	SIM, SINASC
M4	Gestantes com seis ou mais consultas de pré-natal	a medir em 2027	70%	80%	SIASI, SINASC
Eixo 2. Doenças transmissíveis e vacinas					
M5	Incidência de tuberculose, por 100 mil	71,7 (2011 a 2022)	64,5	até 53,8	SINAN
M6	Cura dos casos novos de tuberculose	a medir em 2027	80%	85%	SINAN
M7	Óbitos evitáveis por malária em áreas endêmicas monitoradas	queda de 80,8% na Terra Yanomami (2025)	zero na Terra Yanomami	zero em todas as áreas	SIVEP-Malária, COE
M8	Distritos com coberturas vacinais infantis nas metas do PNI	a medir em 2027	25	34	SIPNI, SIASI
Eixo 3. Bem viver e saúde mental					
M9	Mortalidade por suicídio no SasiSUS, por 100 mil	17,2 (2022)	15,5	até 13,8	SIASI, SIM
M10	Mortalidade por suicídio no DSEI Mato Grosso do Sul, por 100 mil	39,1 (2025)	33,0	até 27,0	SIASI
M11	Pessoas com tentativa de suicídio acompanhadas em até 72 horas	a medir em 2027	80%	100%	Prontuário, SIASI
Eixo 4. Doenças crônicas, alimentação e segurança alimentar					
M12	Pessoas com hipertensão e diabetes com controle registrado no semestre	a medir em 2027	50%	70%	Prontuário
M13	Desnutrição crônica em menores de 5 anos	a medir em 2027	menos 10%	menos 20%	SISVAN Indígena
M14	Distritos com entrega domiciliar de medicamentos contínuos	a medir em 2027	20	34	SESAI
Eixo 5. Saúde indígena na cidade					

M15	Indígenas urbanos cadastrados no piloto de Campo Grande com acompanhamento ativo	sem atendimento diferenciado	50%	80% ou mais	SIASI urbano
M16	Registros de pessoas indígenas na APS com etnia preenchida	a medir em 2027	80%	95%	e-SUS APS
M17	Regiões metropolitanas com atenção diferenciada urbana	nenhuma	1 (piloto)	5	SESAI
Eixo 6. Saúde Digital Indígena					
M18	UBSI conectadas à internet	mais de 700 pontos (abr. 2025)	100%	100% com redundância	Ministério das Comunicações
M19	Distritos com telessaúde especializada	19 de 34 (abr. 2025)	34	34 com cinco especialidades	SEIDIGI
M20	Equipes com prontuário eletrônico integrado à RNDS	a medir em 2027	60%	100%	RNDS
Eixo 7. Profissionais, urgência e acesso a especialistas					
M21	Médicos em atuação nos territórios	716 (2025)	850	1.000 ou mais	CNES, AgSUS
M22	Agentes indígenas com formação técnica; Distritos com turma de técnicos de enfermagem indígenas	a medir em 2027; experiência em MS	25%; 10	50%; 34	SESAI, escolas técnicas do SUS
M23	Distritos com SAMU Indígena	1 (Dourados, 2025)	3	5 ou mais	SAE
M24	Tempo entre a indicação e a consulta especializada	a medir em 2027	menos 15%	menos 30%	Sistema de regulação
Eixo 8. Água, saneamento e moradia saudável					
M25	Aldeias com água tratada	diagnóstico em 2027	mais 10 p.p.	mais 20 p.p.	SESAI
M26	Incidência de doença diarreica aguda em menores de 5 anos	a medir em 2027	menos 15%	menos 30%	SIASI
Eixos 9 e 10. Medicinas indígenas; território, produção e saúde					
M27	Distritos com especialistas das medicinas indígenas em cuidado compartilhado	Portaria de abril de 2026	17	34	SESAI
M28	Atividades produtivas autorizadas em terra indígena com Avaliação de Impacto em Saúde	sem exigência	100% das novas	100%	SESAI, órgãos licenciadores
Eixo 11. Gestão, integridade e transparência					
M29	Distritos com painel mensal publicado	sem publicação mensal	34	34 com dados abertos	Portal do Ministério da Saúde
M30	Contratos e convênios com metas e pagamento vinculado a desempenho	a medir em 2027	60%	100%	SESAI, CGU
M31	Execução da dotação anual das ações essenciais	a medir em 2027	95%	95%	SIAFI, SIOP

Notas: trajetórias de M1, M3, M5, M9 e M10 calculadas por redução linear a partir de 2026. Indicadores com poucos eventos, como o suicídio em um único Distrito (35 óbitos em 2025), oscilam muito de um ano para outro; por isso serão avaliados por média móvel de três anos, com intervalo de confiança de 95%. A queda de 25% da mortalidade de menores de cinco anos em

quatro anos exige ritmo médio de cerca de 7% ao ano, compatível com o que se obteve na Terra Yanomami entre 2023 e 2024, quando o número de óbitos caiu 20%.

Figura 6. Trajetória das metas de mortalidade infantil e de suicídio



Elaboração própria com base nas linhas de base da Tabela 8.

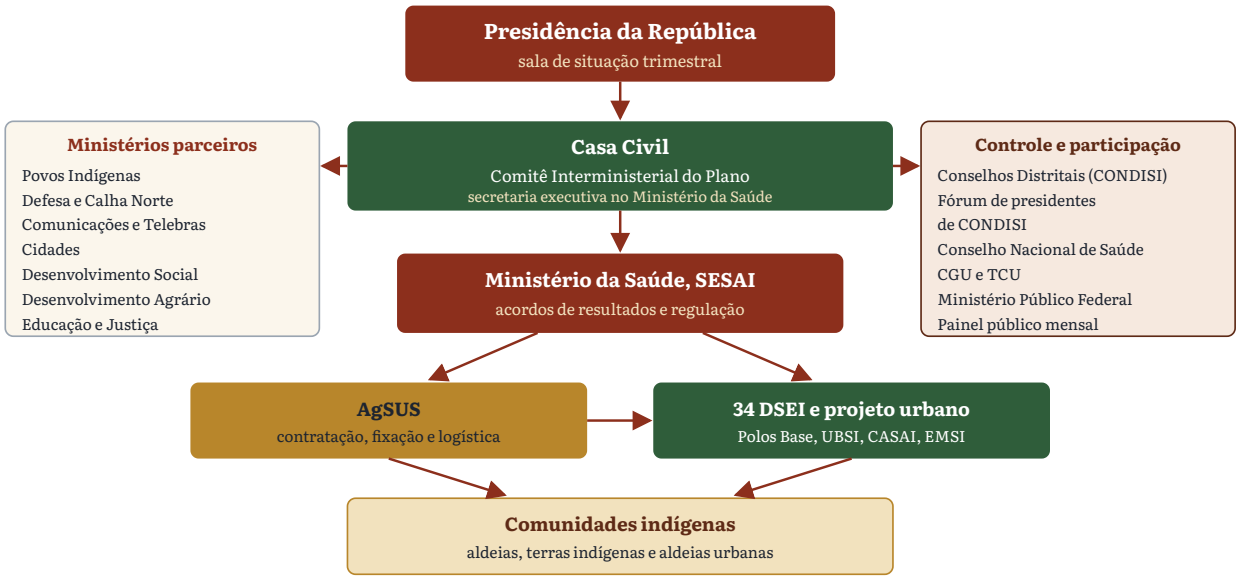
8 Governança e execução

A governança tem três níveis: a coordenação política na Presidência, a execução no Ministério da Saúde e a operação nos 34 Distritos. O controle social indígena e os órgãos de controle participam de todos eles, com acesso aos mesmos números.

Relação com o CONDISI de Mato Grosso do Sul e com o controle social

O Plano será enviado ao Conselho Distrital de Saúde Indígena de Mato Grosso do Sul (CONDISI-MS), para que o conselho, se assim decidir, inclua as propostas que considerar pertinentes em seu planejamento, como o Plano Distrital de Saúde Indígena. O Plano não se sobrepõe às decisões do conselho. Ele considera as políticas e deliberações já aprovadas pelo CONDISI-MS, pelos conselhos locais de saúde indígena, pelo Fórum de Presidentes de CONDISI, pelas conferências de saúde indígena e pelo Conselho Nacional de Saúde, instâncias em que a participação indígena é assegurada pela Lei nº 8.080/1990, com as alterações da Lei nº 9.836/1999. O mesmo envio será oferecido aos demais CONDISI do país.

Figura 7. Estrutura de governança do Plano



Elaboração própria. O Ministério dos Povos Indígenas é citado com a denominação atual; a referência vale para o órgão que vier a sucedê-lo em eventual reorganização ministerial.

Tabela 9. Atribuições na execução

Instância	Atribuição principal	Periodicidade
Presidência da República	Sala de situação com os ministros, decisão sobre entraves e cobrança de resultados	trimestral
Comitê Interministerial (Casa Civil)	Coordenar os ministérios parceiros, aprovar o plano anual e acompanhar o painel	mensal

Ministério da Saúde e SESAI	Executar, firmar acordos de resultados com os Distritos, regular e avaliar	contínua
AgSUS	Contratar e fixar profissionais, gerir logística e executar o contrato de gestão por metas	contínua
Distritos e projeto urbano	Operar a atenção, alimentar o prontuário e prestar contas ao CONDISI	contínua
CONDISI e controle social	Deliberar sobre o Plano Distrital e fiscalizar o cumprimento das metas	trimestral
CGU, TCU e MPF	Auditar, apurar desvios e acompanhar o cumprimento das decisões judiciais	conforme programação

9 Financiamento e responsabilidade fiscal

O Plano foi desenhado para caber no regime fiscal da Lei Complementar nº 200/2023. A maior parte das metas depende de usar melhor o que já existe: equipes, contratos, conectividade em implantação e o programa de saneamento já aprovado. O que exige recurso novo está identificado, e cada real novo fica ligado a uma meta.

9.1 Referências orçamentárias

Tabela 10. Valores de referência do orçamento da saúde indígena

Referência	Valor	Fonte
Orçamento da SESAI em 2022	R$ 1,5 bilhão	IEPS, citado na proposta do CMDDI
Orçamento da SESAI em 2025	R$ 2,9 bilhões	IEPS, citado na proposta do CMDDI
Proposta do Executivo no PLOA 2025	R$ 3,79 bilhões	Ministro da Saúde, em resposta ao relatório do Inesc
Corte no relatório parlamentar do PLOA 2025, depois recomposto	R$ 1,6 bilhão	idem
Saneamento indígena previsto para 2026	R$ 187 milhões	Instituto Água e Saneamento
Programa de saneamento indígena em 20 anos	R$ 10,85 bilhões	idem
Piloto de saúde indígena urbana em Mato Grosso do Sul, por ano	R$ 46,1 milhões	Proposta técnica do CMDDI (2026)

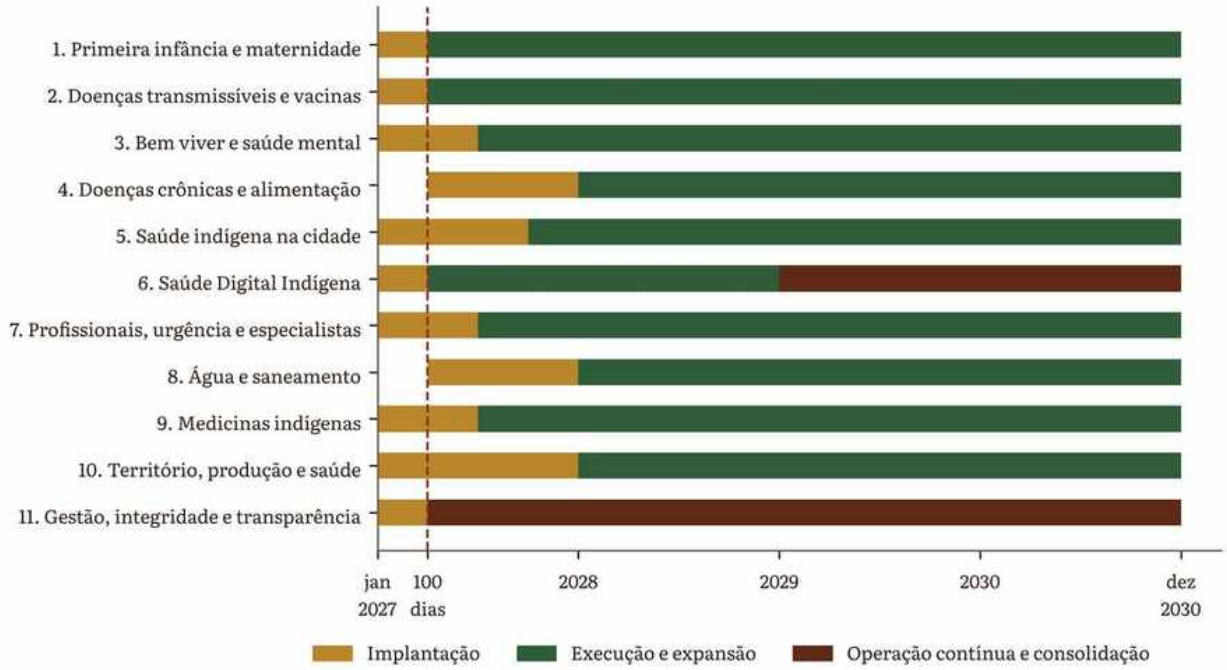
Nota: as séries de diferentes fontes usam conceitos distintos (dotação, proposta, execução). Por isso o Plano adota como primeira providência a publicação de uma série oficial única, por ação orçamentária e por Distrito.

9.2 Seis regras de financiamento

1. **Proteção contra cortes.** Propor, na LDO de 2028 e seguintes, a inclusão das ações essenciais da saúde indígena entre as despesas ressalvadas da limitação de empenho, como permite o art. 9º, § 2º, da Lei Complementar nº 101/2000.
2. **Piso real.** Usar como referência mínima o valor proposto pelo Executivo no PLOA 2025, corrigido pela inflação.
3. **Distribuição por necessidade.** Aplicar a partir do PLOA 2027 os critérios técnicos de redistribuição entre Distritos registrados no encerramento da ADPF 709, com peso para mortalidade infantil, dispersão geográfica e custo logístico.
4. **Economia que financia expansão.** Compras centralizadas, controle das horas de voo e telessaúde reduzem desperdício; a economia apurada fica no Subsistema.
5. **Emendas com meta.** Emendas parlamentares destinadas a estruturação de UBSI, CASAI e saneamento seguem a priorização do painel, com contrapartida de resultado.
6. **Expansão urbana em fases.** O piloto de Campo Grande custa cerca de R$ 1.650 por indígena urbano por ano (proposta do CMDDI). Com esse parâmetro, atender 100 mil indígenas urbanos custaria cerca de R$ 165 milhões anuais, valor a confirmar na avaliação do piloto.

10 Cronograma e entregas dos 100 dias

Figura 8. Cronograma de execução dos onze eixos, 2027 a 2030



Elaboração própria.

Tabela 11. Entregas dos primeiros 100 dias de governo

Prazo	Entrega	Responsável
Dia 1 a 10	Publicação do decreto que institui o Plano e o Comitê Interministerial	Presidência, Casa Civil
Dia 15	Instalação da sala de situação e primeira reunião do Comitê	Casa Civil, Ministério da Saúde
Dia 30	Diagnóstico de equipes incompletas, contratos e vazios assistenciais nos 34 Distritos	SESAI, AgSUS
Dia 30	Portaria do projeto piloto de saúde indígena urbana em Campo Grande	Ministério da Saúde
Dia 45	Primeiro painel público com os dados disponíveis de cada Distrito	SESAI, SEIDIGI
Dia 45	Apresentação do Plano ao Fórum de Presidentes de CONDISI e às organizações indígenas, em processo de consulta conforme a Convenção nº 169 da OIT	Ministério da Saúde, SESAI
Dia 60	Lista nominal de gestantes e crianças menores de cinco anos em todos os Distritos	Distritos
Dia 60	Plano de resposta ao suicídio em Mato Grosso do Sul, com reforço de psicólogos	SESAI, DSEI-MS
Dia 75	Minuta de acordo de resultados apresentada aos 34 CONDISI	SESAI
Dia 90	Envio ao Congresso do projeto de lei da saúde indígena na cidade (Anexo B)	Presidência
Dia 100	Acordos de resultados assinados e prestação de contas pública dos 100 dias	Presidência, SESAI

11 Riscos e respostas

Tabela 12. Matriz de riscos

Risco	Chance	Impacto	Resposta
Contingenciamento ou corte orçamentário	média	alto	Ressalva na LDO, piso real e painel que torna visível o efeito de cada corte
Falta de médicos em áreas remotas	alta	alto	Adicional de área remota, escala com descanso, telessaúde e formação de estudantes indígenas
Dados de baixa qualidade	alta	médio	Linha de base medida em 2027, auditoria de dados e prontuário que funciona sem internet
Resistência à cobrança por metas	média	médio	Acordos negociados com os Distritos e reconhecimento público dos melhores resultados
Conflito com municípios no eixo urbano	média	médio	Termos de cooperação que não retiram recursos municipais e reduzem a pressão sobre a rede local
Invasões e garimpo ilegal	alta	alto	Equipes integradas às operações de fronteira e retorno ao território em até 72 horas
Questionamento judicial de atividades produtivas	média	alto	Consulta prévia, autorização na forma do art. 231, § 3º, e Avaliação de Impacto em Saúde antes do início
Uso indevido de dados pessoais	baixa	alto	Regras da LGPD, acesso por perfil, registro de acessos e publicação apenas agregada

12 Monitoramento, avaliação e transparência

O Plano será acompanhado em quatro ritmos. Todo mês, o painel público de cada Distrito é atualizado com os indicadores disponíveis. A cada trimestre, a sala de situação presidencial examina os Distritos com pior desempenho e decide as medidas de correção. A cada ano, a SESAI publica o relatório consolidado e os CONDISI avaliam o Plano Distrital. Em 2028 e em 2030, uma instituição independente de pesquisa em saúde pública faz a avaliação de meio termo e a avaliação final, com acesso integral aos dados.

O piloto urbano de Campo Grande terá avaliação própria, com comparação entre os indígenas cadastrados e os ainda não alcançados, para medir efeito sobre internações evitáveis, controle de doenças crônicas e satisfação dos usuários. A expansão para outras regiões metropolitanas só ocorre se a avaliação confirmar o resultado.

Efeito da qualificação dos registros sobre as taxas

Quando a busca ativa e o relacionamento de bases passam a captar óbitos e nascimentos antes não registrados, as taxas tendem a subir no primeiro ano, sem que a situação real tenha piorado. O Plano trata esse efeito de forma explícita: as linhas de base serão recalculadas em 2027 com os dados corrigidos, e o relatório anual separará o efeito da melhoria do registro do efeito das ações. Esse procedimento evita que a melhoria do registro seja interpretada como piora da situação de saúde.

Conteúdo do painel mensal

Para cada Distrito: óbitos de menores de cinco anos e de gestantes, coberturas vacinais, casos e curas de tuberculose, casos de malária, tentativas e óbitos por suicídio, profissionais em atividade, UBSI conectadas, remoções realizadas e tempo de resposta, e execução orçamentária. Os dados são agregados de modo a não identificar pessoas nem pequenas comunidades.

13 Conclusão

O Brasil dispõe de 34 Distritos, mais de mil unidades nas aldeias, uma agência capaz de contratar e fixar profissionais, conectividade em expansão e uma experiência recente, na Terra Yanomami, que provou que a mortalidade cai quando há método, presença e cobrança. O desafio é converter essa estrutura em resultados medidos regularmente e estender o cuidado diferenciado à maioria indígena que hoje vive nas cidades.

O Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas propõe esse caminho, sem nova estrutura administrativa, dentro da Constituição e do regime fiscal. Pode ser iniciado por decreto, prevê entregas nos primeiros 100 dias e estabelece metas verificáveis por qualquer cidadão. O cumprimento das metas até 2030 representará redução expressiva da mortalidade de crianças indígenas e da distância entre os indicadores de saúde dos povos indígenas e os do restante da população.

Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 26 de outubro de 2026.

Documento assinado eletronicamente pelo serviço de assinatura digital do gov.br (Lei nº 14.063/2020). Cada signatário aplica sua assinatura no espaço reservado acima de seu nome.

Espaço para assinatura digital gov.br	*Espaço para assinatura digital gov.br*	*Espaço para assinatura digital gov.br*
Aguinaldo de Arruda Areco *Indígena Terena* Presidente Pela Diretoria do Fórum dos Caciques de Mato Grosso do Sul (FOCAMS)	**Maria Auxiliadora Bezerra** Presidente do Instituto Cacique Enir Terena (ICET) Consultoria institucional técnica Responsável pelos projetos	**Germano Coelho Ramos Rocha-Silva** *Indígena Terena* Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação Responsável pelos projetos

Referências

AGÊNCIA BRASIL. Mortalidade de crianças indígenas é mais que o dobro das não indígenas. Brasília, abr. 2024.

AGÊNCIA BRASIL. Óbitos por malária na terra Yanomami caíram 80% em 2025, diz governo. Brasília, abr. 2026.

AGÊNCIA BRASIL. Saúde cria comitê para reduzir morte materna e infantil indígena. Brasília, jun. 2026.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, com os arts. 19-A a 19-H incluídos pela Lei nº 9.836, de 23 de setembro de 1999.

BRASIL. Decreto nº 3.156, de 27 de agosto de 1999. Dispõe sobre as condições para a prestação de assistência à saúde dos povos indígenas.

BRASIL. Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019. Consolida atos normativos que dispõem sobre a promulgação de convenções da OIT, entre elas a Convenção nº 169.

BRASIL. Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019. Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021. Lei nº 14.510, de 27 de dezembro de 2022. Lei nº 14.621, de 14 de julho de 2023.

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Lei Complementar nº 200, de 30 de agosto de 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 254, de 31 de janeiro de 2002 (PNASPI). Portaria GM/MS nº 9.262, de 30 de dezembro de 2025. Portaria GM/MS nº 10.676, de 2 de abril de 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. SasiSUS completa 27 anos e representa marco à atenção à saúde dos povos indígenas. Brasília, set. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Sesai apresenta balanço de 2025 com avanços históricos na saúde indígena. Brasília, dez. 2025.

BRASIL. Ministério da Saúde. Avanços na assistência em saúde reduzem em 27,6% os óbitos no território Yanomami em 2025. Brasília, nov. 2025.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 709. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Medida cautelar referendada em 5 ago. 2020; ação extinta em sessão virtual encerrada em 26 set. 2025.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Propostas de governo dos candidatos ao cargo de Presidente da República, Eleições 2026: Lula. Diretrizes para o Programa de Transformação do Brasil.

BRASIL. Lei nº 14.621, de 14 de julho de 2023 (Programa Mais Médicos).

CONASS. Informe da Comissão Intergestores Tripartite, maio de 2026: relatório situacional da SESAI sobre a Terra Indígena Yanomami.

CONGRESSO EM FOCO. PT registra novo plano de governo de Lula no TSE: veja a íntegra. 2026.

EXAME. Plano de governo de Lula: o que o petista propõe para um 4º mandato. São Paulo, 2026.

CIDACS/FIOCRUZ. Taxa de suicídio entre indígenas é mais que o dobro da população brasileira, afirma estudo. Salvador, out. 2023.

AGÊNCIA SENADO. Curso de enfermagem indígena recebe reconhecimento na Comissão de Educação. Brasília, 11 jun. 2026. Senado Federal, Comissão de Educação e Cultura, audiência pública de 11 de junho de 2026 (Requerimento nº 32/2026).

INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE. SAMU Indígena conta com participação de egressos da Escola Vital Brasil. Dourados, dez. 2025.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO EM MATO GROSSO DO SUL. Acordo garante registro profissional para jovens enfermeiros indígenas. Campo Grande.

MATO GROSSO DO SUL. Secretaria de Estado de Saúde. Saúde certifica Agentes Indígenas de Saúde e Saneamento no interior do Estado. Campo Grande, 2023. Revista de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul: relato da qualificação de agentes indígenas de saúde e de saneamento pela Escola Técnica do SUS (2019 a 2022).

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS E DEFESA DOS POVOS INDÍGENAS DE CAMPO GRANDE (CMDDI). Proposta técnica: plano de implementação da atenção à saúde dos povos indígenas urbanos e de território no Estado de Mato Grosso do Sul. Campo Grande, 15 maio 2026; aprovada em plenária extraordinária em 29 maio 2026.

IBGE. Censo Demográfico 2022: indígenas, principais características das pessoas e dos domicílios. Rio de Janeiro, 19 dez. 2024.

IBGE. Censo Demográfico 2022: etnias e línguas indígenas. Rio de Janeiro, out. 2025.

INESC. PLOA 2026 expõe compressão do orçamento social e crescimento das despesas financeiras. Brasília, 2025.

INSTITUTO ÁGUA E SANEAMENTO. Governo quer investir R$ 187 milhões em saneamento indígena em 2026. 2025.

NÚCLEO CIÊNCIA PELA INFÂNCIA (NCPI). Desigualdades em saúde de crianças indígenas. São Paulo, 2024.

REVISTA BRASILEIRA DE EPIDEMIOLOGIA. Incidência de tuberculose em populações indígenas no Brasil, 2011 a 2022. v. 26, e230055, 2023.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Auditoria operacional na resposta à emergência em saúde pública na Terra Indígena Yanomami, conforme noticiado pelo Jornal de Brasília.

Anexo A. Minuta de decreto presidencial

DECRETO Nº , DE DE DE 2027

Institui o Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas para o período de 2027 a 2030, e o Comitê Interministerial de acompanhamento.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 19-A a 19-H da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e na Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, promulgada na forma do Decreto nº 10.088, de 5 de novembro de 2019,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas para o período de 2027 a 2030, com a finalidade de reduzir a mortalidade e as desigualdades em saúde dos povos indígenas, por meio de ações coordenadas, metas verificáveis e transparência.

Art. 2º O Plano observará as seguintes diretrizes: I. atenção diferenciada aos povos indígenas, independentemente do local de residência; II. gestão por resultados, com metas por Distrito Sanitário Especial Indígena; III. participação e controle social indígena, com respeito às deliberações já aprovadas pelos Conselhos Distritais de Saúde Indígena e pelas demais instâncias de controle social; IV. integração dos conhecimentos e práticas das medicinas indígenas; V. transparência ativa, com publicação mensal de indicadores agregados; VI. proteção de dados pessoais, nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

Art. 3º O Plano organiza-se em onze eixos: I. primeira infância e maternidade segura; II. doenças transmissíveis e vacinas; III. bem viver e saúde mental; IV. doenças crônicas, alimentação e segurança alimentar; V. saúde indígena na cidade; VI. saúde digital indígena; VII. profissionais, urgência e acesso a especialistas; VIII. água, saneamento e moradia saudável; IX. medicinas indígenas e conhecimentos tradicionais; X. território, produção e saúde; XI. gestão, integridade e transparência.

Parágrafo único. As metas, os indicadores e os prazos de cada eixo serão estabelecidos em ato do Ministro de Estado da Saúde, publicado em até sessenta dias da data de publicação deste Decreto.

Art. 4º Fica instituído o Comitê Interministerial do Plano Nacional de Saúde dos Povos Indígenas, com a finalidade de coordenar e monitorar a execução do Plano, composto por representantes dos seguintes órgãos: I. Casa Civil da Presidência da República, que o coordenará; II. Ministério da Saúde, que exercerá a secretaria executiva; III. Ministério dos Povos Indígenas; IV. Ministério da Defesa; V. Ministério das Comunicações; VI. Ministério das Cidades; VII. Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome; VIII. Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; IX. Ministério da Educação; X. Ministério da Justiça e Segurança Pública.

§ 1º Serão convidados a participar das reuniões do Comitê, sem direito a voto, representantes do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena e do Conselho Nacional de Saúde.

§ 2º O Comitê reunir-se-á mensalmente e apresentará relatório trimestral ao Presidente da República.

§ 3º A participação no Comitê será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada.

Art. 5º A Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde celebrará acordo de resultados anual com cada Distrito Sanitário Especial Indígena, com as metas do Plano desdobradas por território, submetido à apreciação do respectivo Conselho Distrital de Saúde Indígena.

Art. 6º O Ministério da Saúde publicará, mensalmente, painel com os indicadores do Plano por Distrito Sanitário Especial Indígena, em formato aberto, com dados agregados que impeçam a identificação de pessoas e de pequenas comunidades.

Art. 7º Os contratos de gestão, convênios e instrumentos congêneres firmados para execução de ações de saúde indígena conterão metas vinculadas ao Plano e critérios de avaliação de desempenho.

Art. 8º A implementação deste Decreto não implicará aumento de despesa nem criação de cargos, e as ações do Plano correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas aos órgãos participantes.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, de de 2027.

Anexo B. Minuta de projeto de lei da saúde indígena na cidade

PROJETO DE LEI Nº , DE 2027

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para explicitar a atenção diferenciada à saúde dos indígenas que residem em áreas urbanas e em terras indígenas não homologadas.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º O art. 19-A da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos:

"Art. 19-A. .....

§ 1º A atenção à saúde de que trata este Capítulo abrange os indígenas que residam em terras indígenas em qualquer fase do procedimento de demarcação, em áreas rurais e em áreas urbanas, observado o critério de autoidentificação.

§ 2º A atenção diferenciada aos indígenas residentes em áreas urbanas será prestada de forma complementar às ações e serviços do SUS de responsabilidade dos Estados e Municípios, sem prejuízo das transferências a eles devidas, mediante instrumentos de cooperação.

§ 3º O Poder Executivo federal manterá sistema de informação que identifique os indígenas atendidos em áreas urbanas, com dados desagregados por etnia, observada a legislação de proteção de dados pessoais." (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificação resumida. O Censo 2022 mostrou que 53,97% dos indígenas brasileiros vivem em áreas urbanas. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 709, e a Justiça Federal em Mato Grosso do Sul, na Ação Civil Pública nº 5004426-89.2020.4.03.6000, já reconheceram o direito desse público à atenção diferenciada. A alteração dá segurança jurídica ao que as decisões judiciais determinaram, evita litígios repetitivos e organiza a cooperação com os municípios sem transferir a eles a responsabilidade financeira que a lei atribui à União.